Questions — rectos

Carte 01

Comment définir une hépatite ?

Carte 02

Quelles sont trois fonctions hépatiques utiles à connaître ?

Carte 03

Pourquoi des transaminases élevées ne suffisent-elles pas à identifier un virus ?

Carte 04

L'absence de symptôme exclut-elle une hépatite ou une contagiosité ?

Carte 05

Quels signes associer pour comprendre la gravité fulminante ?

Carte 06

Quelle évolution peut relier inflammation persistante, fibrose et cirrhose ?

Réponses — versos correspondants

Carte 02

Contrôle métabolique et stockage, synthèse d'albumine et de facteurs de la coagulation, transformation de l'ammoniaque en urée.

Carte 01

Une hépatite est une inflammation aiguë ou chronique du foie ; elle n'est pas nécessairement virale.

Carte 04

Non. Une infection peut être silencieuse tout en pouvant évoluer ou se transmettre.

Carte 03

Elles renseignent sur une atteinte cellulaire ; des marqueurs spécifiques sont nécessaires pour en rechercher la cause.

Carte 06

Une inflammation chronique peut entraîner un tissu cicatriciel, puis un remaniement cirrhotique du foie.

Carte 05

Insuffisance hépatique aiguë, anomalies de coagulation et troubles de conscience ; d'autres organes peuvent aussi défaillir.

Questions — rectos

Carte 07

Que désignent ascite et circulation collatérale ?

Carte 08

Une hépatite est-elle toujours d'origine virale ?

Carte 09

Comment définir la période d'incubation ?

Carte 10

Quels sont les deux grands objectifs du dépistage des hépatites chroniques ?

Carte 11

Quel est le principe d'une transmission féco-orale ?

Carte 12

Quel est le réservoir de l'hépatite A ?

Réponses — versos correspondants

Carte 08

Non. Des causes médicamenteuses, métaboliques, alcooliques ou auto-immunes sont également possibles.

Carte 07

L'ascite est une accumulation de liquide abdominal ; les collatérales sont des voies veineuses de dérivation.

Carte 10

Prendre en charge avant les complications et contribuer à prévenir la transmission.

Carte 09

C'est le délai entre la contamination et l'apparition éventuelle de signes de la maladie.

Carte 12

Le réservoir est humain ; les selles des personnes infectées peuvent contaminer l'environnement ou les aliments.

Carte 11

Un agent d'origine fécale atteint la bouche, directement ou via mains, objets, eau ou aliments.

Questions — rectos

Carte 13

Pourquoi une personne sans symptôme peut-elle transmettre A en préparant des aliments ?

Carte 14

Pourquoi distinguer A et E malgré leur porte d'entrée digestive ?

Carte 15

Comment définir une infection zoonotique ?

Carte 16

Pourquoi la surgélation ne suffit-elle pas à garantir la sécurité d'un aliment contaminé ?

Carte 17

Quels anticorps sont recherchés pour A et E aiguës dans le bilan enseigné ?

Carte 18

Quelles sont les grandes familles de prévention de A ?

Réponses — versos correspondants

Carte 14

Le réservoir et l'origine de la contamination diffèrent : humain pour A, animal dans les situations E étudiées.

Carte 13

Elle peut excréter le virus avant les signes ; une contamination des mains peut ensuite atteindre les aliments.

Carte 16

Elle ne doit pas être assimilée à une stérilisation ; un lot contaminé peut rester une source d'exposition.

Carte 15

C'est une infection dont le réservoir ou la transmission implique des animaux.

Carte 18

Hygiène individuelle, sécurité collective de l'eau et des aliments, et vaccination dans les situations indiquées.

Carte 17

Des immunoglobulines M spécifiques : anti-VHA et anti-VHE.

Questions — rectos

Carte 19

Quels moyens de prévention relier au contexte zoonotique de E ?

Carte 20

Quel est le but d'identifier contacts et aliments impliqués lors de cas groupés A ?

Carte 21

Quelles sont les trois voies de transmission B à connaître ?

Carte 22

Quelle voie de contamination faut-il principalement rechercher pour C ?

Carte 23

Pourquoi éviter la phrase « C ne se transmet jamais dans un contexte sexuel » ?

Carte 24

Pourquoi la prévention de la contamination B très précoce est-elle essentielle ?

Réponses — versos correspondants

Carte 20

Interrompre la transmission et organiser les mesures adaptées aux personnes, aux lieux ou aux lots concernés.

Carte 19

Cuisson à cœur des produits concernés et protection adaptée aux contacts avec des animaux potentiellement infectés.

Carte 22

Une exposition au sang, notamment par un matériel partagé ou un soin non sécurisé.

Carte 21

Les voies sanguine, sexuelle et mère-enfant.

Carte 24

Une contamination très précoce expose davantage à la persistance de l'infection.

Carte 23

Certaines situations sexuelles peuvent exposer au virus ; une voie sanguine dominante n'exclut pas tout contexte sexuel.

Questions — rectos

Carte 25

Le dépistage B ou C doit-il attendre des symptômes ?

Carte 26

Quel est l'objectif majeur du dépistage B pendant la grossesse ?

Carte 27

Pourquoi distinguer facteur de risque et diagnostic ?

Carte 28

Que désigne un AES et quel est le premier raisonnement à avoir ?

Carte 29

Quelles sont trois barrières de prévention des transmissions sanguines ?

Carte 30

Le VIH implique-t-il automatiquement une hépatite B ?

Réponses — versos correspondants

Carte 26

Identifier une infection maternelle afin d'organiser la prévention de la transmission à l'enfant.

Carte 25

Non. Il peut être indiqué selon les expositions et le contexte, avant les complications.

Carte 28

Un accident d'exposition au sang ; il faut recourir au circuit prévu et faire évaluer l'exposition.

Carte 27

Un facteur de risque décrit une possibilité d'exposition ; le diagnostic nécessite des examens et une interprétation individualisée.

Carte 30

Non. Des risques communs justifient un dépistage, mais le statut B doit être établi séparément.

Carte 29

Matériel non partagé et adapté, procédures de soin respectées, sécurisation des dons et produits destinés aux receveurs.

Questions — rectos

Carte 31

Quels trois marqueurs faut-il lire ensemble pour B ?

Carte 32

Quelle différence fondamentale existe entre AgHBs et anti-HBs ?

Carte 33

Quel profil sérologique B est présenté comme vaccinal ?

Carte 34

Que suggèrent des anticorps anti-HBc dans le bilan enseigné ?

Carte 35

Que doit faire comprendre un AgHBs détecté ?

Carte 36

Quelle différence faut-il expliquer entre anti-VHC et ARN du VHC ?

Réponses — versos correspondants

Carte 32

AgHBs est un antigène viral ; anti-HBs désigne des anticorps dirigés contre cet antigène.

Carte 31

L'antigène HBs, les anticorps anti-HBs et les anticorps anti-HBc.

Carte 34

Ils témoignent d'un contact avec le virus B ; ils ne résultent pas du seul vaccin fondé sur HBs.

Carte 33

AgHBs négatif, anti-HBs positifs, anti-HBc négatifs.

Carte 36

Les anti-VHC indiquent une trace immunitaire ; l'ARN renseigne sur la présence de virus circulant.

Carte 35

Il fait rechercher une infection B en cours et appelle une évaluation adaptée, plutôt qu'une lecture isolée du résultat.

Questions — rectos

Carte 37

Pourquoi compléter une sérologie C positive par une recherche d'ARN ?

Carte 38

Des anti-VHC persistants après traitement signifient-ils nécessairement un virus encore présent ?

Carte 39

Que signifie DGV et que recherche-t-il ?

Carte 40

Comment rassurer sans promettre après un résultat C positif ?

Carte 41

Qu'est-ce qu'un vaccin sous-unitaire dans le cas de B ?

Carte 42

Pourquoi avoir reçu des injections B ne suffit-il pas toujours à prouver l'immunisation ?

Réponses — versos correspondants

Carte 38

Non. Il faut distinguer la trace immunitaire de la recherche de virus circulant.

Carte 37

Pour savoir si du virus circule, car des anticorps peuvent persister sans infection active détectée.

Carte 40

Expliquer qu'une prise en charge efficace existe, préciser les examens et le suivi, puis vérifier la compréhension.

Carte 39

Dépistage du génome viral : recherche de matériel génétique viral dans le don de sang, complémentaire des contrôles du donneur.

Carte 42

La réponse individuelle doit être établie ; une non-réponse peut exister et nécessite une interprétation médicale.

Carte 41

Un vaccin utilisant l'antigène de surface HBs afin de déclencher une réponse immunitaire, sans virus B entier.

Questions — rectos

Carte 43

Quelles informations sont utiles pour établir un statut vaccinal B ?

Carte 44

Quel point doit être transmis lors d'un AES chez un non-répondeur B ?

Carte 45

Quels deux moyens associe la sérovaccination ?

Carte 46

Comment expliquer protection active et protection passive ?

Carte 47

Que faut-il distinguer dans la prévention mère-enfant de B ?

Carte 48

Pourquoi les précautions de soin restent-elles nécessaires après vaccination B ?

Réponses — versos correspondants

Carte 44

Son absence de réponse vaccinale connue, pour guider l'évaluation et la prise en charge médicales.

Carte 43

L'histoire des injections, les résultats biologiques et le contexte médical, interprétés dans le cadre prévu.

Carte 46

Active : le vaccin stimule une réponse propre.
Passive : des immunoglobulines apportent des anticorps déjà disponibles.

Carte 45

Un vaccin qui déclenche une réponse propre et des immunoglobulines qui apportent immédiatement des anticorps.

Carte 48

La vaccination B ne protège ni de toutes les infections ni de toutes les conséquences d'un AES.

Carte 47

Le statut maternel AgHBs, les mesures de protection de l'enfant, les actes réalisés et le suivi à poursuivre.

Questions — rectos

Carte 49

Que signifie soutenir l’adhésion au traitement ?

Carte 50

Quelle règle simple guide la lecture des résultats d’hépatite ?

Réponses — versos correspondants

Carte 50

Identifier ce que mesure le test et l'interpréter avec le contexte ; ne pas confondre anticorps, antigène et virus circulant.

Carte 49

Aider la personne à comprendre et à suivre le traitement convenu, recueillir les difficultés et favoriser le suivi.